

Gdy bliscy „pomagają” OCD

60–80% rodzin uczestniczy w kompulsjach lub ułatwia unikanie. To kochający odruch — który wzmacnia zaburzenie. Trzeba to zmienić razem.

CZAS: sesja rodzinna + ciągłe wdrażanie Wymaga współpracy bliskich

ŹRÓDŁO: Calvocoressi i wsp. (1995, *Family Accommodation Scale*); Lebowitz i wsp. (2020, *JAMA* — SPACE); Storch i wsp. (2007)

JAK UŻYWAĆ

Zidentyfikuj **cztery formy akomodacji**: (1) uczestniczenie w rytuałach, (2) zapewnianie, (3) ułatwianie unikania, (4) modyfikacja otoczenia. *Psychoedukacja bliskich*: te zachowania pomagają chwilowo, ale wzmacniają OCD. **Stopniowe wycofywanie** ustępstw — równoległe z ERP. Formuła kluczowa: „Rozumiem, że to trudne, ale nie pomogę Ci wykonać rytuału”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Akomodacja rodzinna (ang. *family accommodation*; Calvocoressi i wsp., 1995, *Family Accommodation Scale*): **60-80% rodzin** osób z OCD uczestniczy w kompulsjach lub ułatwia unikanie. Storch i wsp. (2007): *wysoka akomodacja* koreluje z **gorszymi wynikami** ERP. Bliscy „pomagają” odpowiadając na powtarzalne pytania, robiąc zakupy za pacjenta (żeby nie musiał dotykać pieniędzy), zdejmując noże z kuchni „żeby nie wyzwałać” — i **wzmacniają OCD**. Każde ustępstwo pomaga chwilowo, utrwała długoterminowo. Lebowitz i wsp. (2020, *JAMA*): **SPACE** (*Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions*) — interwencja *tylko na rodzicach*, bez bezpośredniej pracy z dzieckiem — daje **redukcję OCD u dziecka porównywalną z CBT**. Klucz: walidacja emocji *bez* walidacji kompulsji.

01 ? Cztery formy akomodacji

1 · UCZESTNICZENIE W RYTUAŁACH

Bliscy **też** myją ręce „według procedury”, chodzą w określonej kolejności, używają specjalnych ręczników. *Cała rodzina ma OCD pacjenta*.

2 · ZAPEWNIANIE

Odpowiadanie na powtarzalne pytania „czy będzie OK?”, „czy zamknąłem?”, „czy jestem dobrą osobą?”. **Każde „tak, oczywiście” wzmacnia cykl**.

3 · UŁATWIANIE UNIKANIA

Robienie zakupów za pacjenta, dowożenie do pracy okrężną drogą („*bo szpital*”), unikanie tematów w rozmowie. **Pacjent przestaje konfrontować się**.

4 · MODYFIKACJA OTOCZENIA

Zdejmowanie noży z kuchni „*żeby nie wyzwałać*”, zasłanianie okien, usuwanie pewnych przedmiotów. **Środowisko dostosowuje się do OCD**.

02 ? Paradoxs pomocy

INTENCJA BLISKICH

„Chcemy mu pomóc, zmniejszyć jego cierpienie.”

Akomodujemy z miłości. Patrzenie na kogoś bliskiego w kryzysie OCD jest *nie do zniesienia*. Łatwiej dać zapewnienie niż patrzeć na panikę.

SKUTEK DŁUGOTERMINOWY

OCD pacjenta rośnie. Bliscy żyją „*na palcach*”, pacjent *nie konfrontuje się* z lękiem. Cykl umacnia się.

„Pomagam = przeszkadzam mu wyzdrowieć.”

03 Audyt akomodacji w mojej rodzinie

KTO?	CO KONKRETNIE ROBI (AKOMODACJA)	CZĘSTOTLIWOŚĆ

04 Formuła dla bliskich — walidacja bez ustępstwa

„Kocham Cię i widzę, że to dla Ciebie naprawdę trudne. Rozumiem, że ten lęk jest bardzo silny.

Zgodnie z naszą umową **nie pomogę Ci wykonać tego rytuału**. To byłaby pomoc dla OCD, nie dla Ciebie. **Wierzę, że dasz radę poczekać, aż impuls minie**.

Możemy zająć się czymś innym? Pójść na spacer? Pograć w coś?"

Klucz: walidacja emocji („widzę, że to trudne”) + brak walidacji kompulsji („nie pomogę wykonać rytuału”) + przekierowanie na alternatywę („możemy razem coś innego”).

05 Plan wycofywania — stopniowo

Krok 1. Sesja rodzinna — psychoedukacja, wspólna umowa, lista akomodacji.

Krok 2. Wybór 1-2 form akomodacji do *pierwszego* wycofania (najłatwiejsze).

Krok 3. Wycofywanie *razem z ERP* — bliscy mówią „nie”, pacjent *doświadcza* dyskomfortu.

Krok 4. Stopniowo dodawaj kolejne formy. Co 1-2 tyg. recenzja.

Klucz: Lebowitz i wsp. (2020, *JAMA*): SPACE — pierwsza interwencja, w której *nie pracuje się* bezpośrednio z pacjentem, tylko z bliskimi. Skuteczność **porównywalna** z CBT u dzieci. Dla dorosłych: redukcja akomodacji znacząco poprawia wyniki ERP (Storch 2007). Wymaga *odwagi obu stron*: bliscy muszą znieść widok dyskomfortu pacjenta, pacjent musi znieść brak ustępstwa. Łącz z *eliminacją szukania zapewnienia*. Formuła **„Kocham Cię i nie pomogę”** — najtrudniejsza i najbardziej kochająca rzecz, jaką bliski może powiedzieć osobie z OCD.